Guía Práctica Clínica: Infeccion de vías urinarias en gestantes

CONEXIÓN CLÍNICA

Crecemos en Saber

Hospital Regional de Moniquirá E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

Toda Infección de tracto urinario en gestantes se considera ITU complicada

Tamizaje en todas las gestantes

Antes de la semana 26 o primer control prenatal

UROCULTIVO y ANTIBIOGRAMA

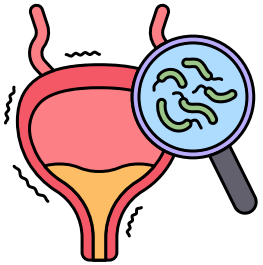
Primer trimestre

FACTORES DE RIESGO

- Historia previa de ITU
- Diabetes mellitus
- Obesidad
- Edad materna joven
- Bajo nivel socioeconómico.

AGENTES ETIOLÓGICOS

- Escherichia coli
- Klebsiella pneumoniae
- Proteus mirabilis
- Enterococcus faecalis
- Staphylococcus saprophyticus



Realizar nuevamente UROCULTIVO si:

Segundo (18 y 22 sem) y tercer trimestre (32 y 34 sem)

Hay factores de riesgo:

- Diabetes Mellitus
- Antecedentes de ITU
- Anemia
- Antecedente malformaciones del tracto urinario
- Inmunosupresión.

TERMINOLOGÍA CLAVE EN INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO (ITU)

- **Bacteriuria asintomática (BAS)** : ≥10^5 UFC/ml, sin síntomas urinarios.
- **Cistitis (ITU baja)**: síntomas urinarios bajos y urocultivo positivo.
- **Pielonefritis (ITU alta)**: fiebre ≥38 °C +dolor en flanco y síntomas sistémicos + urocultivo positivo
- **Persistencia**: Urocultivo postratamiento positivo para el mismo germen.
- **Recidiva:** Urocultivo negativo tras tratamiento, luego urocultivo positivo para el mismo germen.
- **Reinfección**: ITU nueva por un germen diferente.
- **ITU recurrente en embarazo**: ≥1 pielonefritis o >2 cistitis/ BAS durante la gestación.

Tratamiento ITU recurrente en gestación

Profilaxis con:
Cefalexina 250–500 mg VO noche. Iniciar inmediatamente después de completar tratamiento del episodio agudo.

Mantener hasta 1–2 semanas antes de la fecha probable de parto.

Ingesta adecuada de líquidos.
Evitar ropa interior sintética y prendas ajustadas.
Higiene genital adecuada (limpieza anteroposterior).

Pacientes deben tener seguimiento microbiológico periódico y profilaxis antibiótica según la causa y la susceptibilidad antimicrobiana

Guía Práctica Clínica: Infección de vías urinarias en gestantes

CONEXIÓN CLÍNICA

Crecemos en Saber



Paciente gestante con síntomas urinarios y/o urocultivo positivo

CLASIFICAR

ITU vías urinarias baja

ITU vías urinarias alta



BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

DEFINICIÓN

≥10^5 UFC/ml en muestra de micción, sin síntomas urinarios.

TRATAMIENTO

(iniciar después de toma de urocultivo):

- Primera línea: Cefalexina 500 mg VO c/6h × 5–7 días.
- Alternativa: Nitrofurantoína 100 mg VO c/12h × 5–7 días (evitar después de semana 37 por riesgo de hemólisis neonatal).

CONTROL

- Urocultivo 7–10 días después de completar tratamiento.
- Si persiste positiva, repetir tratamiento ajustado según antibiograma

CISTITIS

DEFINICIÓN

- Disuria, polaquiuria, urgencia miccional ± dolor suprapúbico, sin fiebre ni dolor en flanco.
- Urocultivo positivo (≥10^5 UFC/ml).

TRATAMIENTO AMBULATORIO

- Cefalexina 500 mg VO c/6h × 5–7 días.
- Nitrofurantoína 100 mg VO c/12h × 5–7 días (evitar después de semana 37).

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN

- Imposibilidad de asegurar adherencia o seguimiento.
- Síntomas que sugieren progresión a IVU alta (fiebre, dolor lumbar).
- Comorbilidades significativas (ej. diabetes, inmunosupresión).

Esquema hospitalario:
Cefazolina 1 g IV c/6h × 5 días, ajustar según antibiograma

PIELONEFRITIS

DEFINICIÓN

Fiebre ≥38 °C + Dolor en flanco o lumbar ó Síntomas urinarios bajos previos o concomitantes ó náuseas, vómito o malestar general ó taquicardia materna o fetal.

TRATAMIENTO HOSPITALARIO

PARACLINICOS:

- Urocultivo con antibiograma.
- Hemograma y creatinina sérica.
- Hemocultivos si se sospecha sepsis.
- Signos vitales y monitorización fetal según edad gestacional.

- Primera línea: Piperacilina–tazobactam 4.5 g IV c/6h.
- Si BLEE sospechado: Ertapenem 1 g IV c/24h.
- Duración: 10–14 días (puede completar vía oral tras mejoría).

¿MEJORA EN 48 H?

NO: Reevaluar diagnóstico, descartar complicaciones, ajustar antibiótico

SI: Continuar tratamiento y cambio a vía oral para duración total.

Siempre tomar urocultivo antes de iniciar antibióticos.
Reevaluar clínicamente a las 48 h: si no hay mejoría → descartar progresión a pielonefritis.
Evitar: Fluoroquinolonas por perfil institucional de resistencia